

Fecha Última Actualización: 14-02-2023 14:17:26

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Alicia Del Carmen Naguil Huenchullanc
Edad : 71a 1m 29d
Dirección : Duraznal 1589

Rut : 7.264.133-7
Fecha Nacto: 16/12/1951
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A495731
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 8939 2329

N° Epicrisis
338742

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 03/01/2023 22:13

Días Estadía: 42

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 14/02/2023 14:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

PCR

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes:

Médicos: Asma desde la infancia, fibrilación auricular en anticoagulación (suspendido hace 3 meses), tromboembolismo pulmonar (2015), hipertensión arterial, Artrosis, obesidad mórbida, Enf Alzheimer y depresión.

Quirúrgicos: Cesarea, Colectomía

Fármacos: PDN 5mg/día, PCT, Meloxicam, Celecoxib, Tramadol. Berodual (2x3) Brexotide (2x2) Br Ipratropio (a demanda), Quetiapina, Sertralina

Alergias: Penicilina

Hábitos: TBQ (+), IPA 2. OH (-). Drogas (-)

Inmunizaciones: 4 dosis COVID 19, anti flu 2022(+)

Hospitalizaciones: Julio 2021 crisis de asma asociada a NAC.

Social: vive con esposo e hijos, Según datos extraídos de ficha impresiona bajo nivel cognitivo

Motivo de Ingreso: Derivada desde APS posterior a PCR presenciado y recuperado

Anamnesis Próxima:

Paciente con antecedentes descritos consulto inicialmente en APS por cuadro de dolor toracico retroesternal presentando posteriormente paro cardiorrespiratorio presenciado.

Se describe en Monitor de APS, inicialmente con actividad eléctrica sin pulso que posterior a un ciclo de reanimación y 1 dosis de adrenalina recupera. Ingresa al SU en malas condiciones generales con compromiso de consciencia cuantitativo además de presentar pulsos presentes.

Se decide intubación y conexión a ventilación mecánica invasiva e invasión de la paciente en SU. Destaca en sus exámenes de ingreso la presencia de cuadro de insuficiencia respiratoria como eventual causal del paro cardiorrespiratorio dado presencia de retención de CO2. Presumiéndose neumonía + limitación crónica al flujo aéreo. Destaca posterior a su ingreso la presencia de peaks febriles que determinan pancultivo e inicio de terapia antibiótica.

Durante su ingreso presenta episodios de movimientos estereotipados que se interpretan inicialmente como convulsiones que se manejan con Lorazepam. Posteriormente es evaluada por neuroimágenes que no muestran hallazgos agudos.

Posterior a intubación se decide traslado a UPC para continuar estudio y manejo.

Diagnósticos:

Paro cardiorrespiratorio recuperado

Fecha Epicrisis : 14/02/2023 14:17

Página 1 de 2

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 14-02-2023 14:17:26

Página 2 de 2

- Actividad eléctrica sin pulso con retorno a circulación espontánea al primer ciclo a ritmo sinusal

Insuficiencia respiratoria global

Sospecha de Asma vs EPOC exacerbado, secundario a neumonía

Antecedentes: FA, TEP (2015), HTA, Enf Alzheimer, depresión

Evolución durante hospitalización:

Paciente ingresa por paro cardiorrespiratorio que sospecha hipóxico. Se maneja con broncodilatación y corticoides sistémicos, difícil acople a ventilación mecánica. Recibe antibióticos empíricos sin embargo no se logra aislar microbiología. Se logra extubar el 16/01. Sale a UTIM para continuar rehabilitación y manejo.

En UTIM se logra consolidar destete de ventilación mecánica, con requerimiento inicial de ventilación no invasiva. Evoluciona con fiebre persistente, se sospechó foco cutáneo por hematoma en mano derecha sobreinfectado. Además con evidencia de infección urinaria. Se iniciaron antibióticos. Se toman hemocultivos el 06/2 donde se aísla en 1 hemocultivo 2 bacterias (P. aeruginosa y S. haemolyticus). Se mantienen antibióticos ajustados. Se objetiva diarrea por C. difficile, se inicia tratamiento el 12/02.

A pesar de encontrarse todos los posibles focos infecciosos en tratamiento, evoluciona con fiebre persistente. El 13/02 presenta deterioro de conciencia e inicia requerimientos de oxígeno que aumentan rápidamente.

Fallece el 14/02 a las 13:45 hrs.

Diagnóstico de Egreso

Paro cardíaco con resucitación exitosa -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Victoria Polanco Trampe
Médico Tratante (Staff)